

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA

Belo Horizonte, 30 de Janeiro de 2023.

NOME: Cecília Maria Albergaria Silva

Idade: 2 anos e 1 mês

Data de Nascimento: 30/06/20

Filiação:

Solicitante: Dra Luciana Gauzzi - neurologista

Finalidade: Relatório de Avaliação e Acompanhamento

Cecília Maria Albergaria Silva, 2 anos e 1 mês, compareceu à clínica Travessia - Espaço de Desenvolvimento Infantil, foi encaminhada pela terapeuta ocupacional. Em 16/08/22, os pais relataram que Cecília é fruto de uma gestação sem intercorrências. Nasceu através de parto normal, demorado, porém, a recém-nascida apresentou boa vitalidade através da Escala Apgar de 6/7 e não precisou de cuidados médicos. É filha única, reside com seus pais. A necessidade de estimulação precoce dos aspectos do desenvolvimento de linguagem e fala, foi sugerida pela neurologista.

Cecília nasceu com 38 semanas, pequena para a idade gestacional (PIG). Teve alta conjunta com a mãe. No período pós-natal tardio, aos 35 dias de vida, a bebê teve uma convulsão causada por AVE Hemorrágico, uma hemorragia subaracóidea, tratada com derivação ventricular peritoneal (DVP), deixando sequela na região motora inferior. Permaneceu internada por 60 dias. Durante seu desenvolvimento, atingiu os marcos do desenvolvimento após a idade esperada. Está em tratamento profilático com acompanhamento multiprofissional, terapia ocupacional, fisioterapia e academia; acompanhamento com endocrinologista. A criança participa de aula de música e tem boa socialização com seus colegas e primos.

Atualmente, a alimentação é branda, mastiga bem, mantém a boca fechada, não apresenta engasgos (SIC); necessita de 1 hora para finalizar a refeição.

Quanto ao desenvolvimento auditivo, Cecília apresentou resultado normal na Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU), realizada nos primeiros dias de vida, nega episódios de otites e não realizou exames audiológicos recentemente.

Aspectos Avaliados:

Para avaliação da linguagem foi utilizado o teste **Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem – ADL (MENEZES, 2003)**, iniciada pelos itens ou comportamentos esperados para crianças seis meses mais jovens do que a idade cronológica da criança avaliada, assim como orienta o teste; portanto, na faixa etária de 1 ano e 6 meses até 1 ano e 11 meses. Para classificação dos níveis de linguagem, pontuação do Escore Padrão. Na classificação proposta é considerado dentro da faixa de normalidade escores entre 115 e 85, com distúrbio leve entre 84 e 77, com distúrbio moderado entre

76 e 70 e com distúrbio severo igual ou abaixo de 69.

Para analisar a **produção de fala**, foi utilizado o **ABFW Teste de Linguagem Infantil nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática**. Foi aplicado o subteste de Fonologia, a partir de provas de nomeação e imitação e registro de fala em conversa espontânea, ambos registrados em vídeo.

Foi, também, realizada avaliação das estruturas dos lábios, língua e bochechas, bem como as funções miofuncionais orais de respiração, deglutição, mastigação e fala.

Resultados Encontrados:

O escore padrão encontrado na avaliação de linguagem, ADL = 148, estando dentro da faixa de normalidade. Cecília se comunica por meio do código linguístico oral, por vezes, não apresenta boa inteligibilidade da fala. Compreende ordens simples sem pistas gestuais. Identifica figuras de frutas, partes do corpo, meio de transporte e animais. Identifica partes do corpo em si própria. Compreende ações dentro de um contexto. Nomeia objetos. Produz duas palavras justapostas para falar sobre um objeto, pessoa ou acontecimento em uma mesma emissão vocal. Compreende a relação de posse. Adquiriu vocabulário de pelo menos 10 palavras diferentes. No que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo e representativo, observou-se uso apropriado dos objetos. Cecília teve interesse pela brincadeira compartilhada, porém em alguns momentos necessitou de incentivo da mãe para responder às solicitações. Durante as sessões de avaliação, Cecília interagiu bem com a avaliadora. Notou-se que a paciente produz uso de sons onomatopaicos adequadamente.

Quanto às funções miofuncionais orais de respiração, deglutição, mastigação e fala. As estruturas dos lábios, língua e bochechas com tônus adequado, não vibra lábios e língua. A mastigação ocorreu algumas vezes anteriorizada, unilateral e, em alguns momentos há movimentos de rotação da mandíbula, lentificação do movimento da mastigação. A deglutição não apresentou alterações e, o teste de fala apontou processos fonológicos tais como, redução de sílabas [bo]=bola; harmonia consonantal [memelho]=vermelho, Frontalização de velar [tootei]=coloquei, Plosivação de Fricativas [baka]=vaca, ambos processos caracterizam desenvolvimento fonológico adequado para idade da Cecília.

Ao longo das sessões, observou-se baixa intensidade vocal, que compromete a inteligibilidade da sua fala.

Impressão diagnóstica e conclusão:

Diante da história clínica apresentada pelos pais, concluímos que a criança apresenta risco de atraso no desenvolvimento da linguagem e, beneficia-se do tratamento precoce até aqui desenvolvido pela equipe multiprofissional. Cecília se beneficiará da intervenção fonoaudiológica precoce com objetivo profilático de reduzir os riscos de atraso no desenvolvimento da linguagem.

Conduta:

Manter os atendimentos em fonoaudiologia para desenvolvimento de habilidades da comunicação oral, visando sobretudo, desenvolver a aquisição de vocabulário, a articulação da fala e a estruturação de frases. Tais habilidades serão importantes para o desenvolvimento da linguagem

escrita e da leitura. Atendimento semanais, com duração 45 minutos.

No ambiente escolar, a Cecília irá se beneficiar da presença do auxiliar de ensino para acompanhá-la nas dependências da escola e adequar-se à rotina da escola.

Encaminhar ao otorrinolaringologista para averiguação do desenvolvimento auditivo através da avaliação audiológica, por meio da avaliação audiológica comportamental e imitanciometria.

Coloco-me à disposição para esclarecimentos,

Fernanda Alvarenga de Castro

Fonoaudióloga - CRFª 6-2569